



ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය හා යහපැවැත්ම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය [කෙටුම්පත] (2026 - 2035)

කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කොමිෂන් සභාවේ යෝජනා

2026 අප්‍රේල් 20

හැඳින්වීම

කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික කොමිෂන් සභාව, 2024 අංක 37 දරන කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ පනත යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද ස්වාධීන කොමිසමකි. ස්වාධීන, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ම කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීමට මෙම කොමිසමට බලය පැවරී ඇත.

කාන්තාවන් බලගැන්වීමේ පනතේ 2(ආ) වගන්තිය මගින් "කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කොට සැලකීම තුරන් කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය ප්‍රකාරව, කාන්තාවන්ට අදාළව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් භාරගෙන ඇති බැඳීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණ හඳුන්වා දීම" කොමිසමට නියම කර ඇත. මෙම නියෝගයට අනුකූලව, කොමිසම ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්ති කෙටුම්පත (2026-2035) සමාලෝචනය කර ඇති අතර, සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් CEDAW කෙරෙහි ඇති රාජ්‍යයේ බැඳීම් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සහ සහතික කිරීම සඳහා නිර්දේශ හයක් (06) ඉදිරිපත් කරයි.

මෙම කෙටුම්පත සකස් කිරීමේ දී පහත සඳහන් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්ති සහ ප්‍රතිපත්ති සලකා බලන ලදී:

- කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් කිරීම් තුරන් කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය (CEDAW) [සබැඳිය [මෙතනින්](#)].
- කාන්තාවන් සහ සෞඛ්‍යය' පිළිබඳ CEDAW හි 12 වන වගන්තිය පිළිබඳ CEDAW පොදු නිර්දේශ අංක 24 [සබැඳිය [මෙතනින්](#)].
- 2025 පෙබරවාරි 28 වන දිනකි CEDAW කමිටුවේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව 9 වන වාර්තාවේ සමාප්ති නිරීක්ෂණ [සබැඳිය [මෙතනින්](#)].
- 2024 අංක 37 දරන කාන්තාවන් සවිබලගැන්වීමේ පනත [සබැඳිය [මෙතනින්](#)]
- ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව (2024) [සබැඳිය [මෙතනින්](#)].

නිර්දේශ අංක 1

➤ 4 පිටුව, 4 ඡේදය, 1 ඡේදය

දැනට පවතින වගන්තිය:

- සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට ප්‍රවේශය සහ දැරිය හැකි මිල සම්බන්ධයෙන්, වැඩිහිටි පුද්ගලයින්, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්, වතු ප්‍රජාවන් සහ නාගරික දුප්පත් ප්‍රජාව ඇතුළු අවදානමට ලක්වූ කණ්ඩායම්, අඛණ්ඩ ව අසමානතාවයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටී."

නිර්දේශිත සංශෝධනය (නිල් පැහැයෙන්):

පවතින වගන්තිය පහත පරිදි සංශෝධනය කරන්න:

- "ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වන කාන්තාවන් සහ ගැහැනු ළමයින්, වැඩිහිටි පුද්ගලයින්, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්, වතු ප්‍රජාවන්, බහු-විධ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අනන්‍යතාවන් ඇති පුද්ගලයින් සහ නාගරික දුප්පත් ප්‍රජාව ඇතුළු අවදානම් සහිත කණ්ඩායම්, ප්‍රවේශය සහ දැරිය හැකි මිල සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ ව අසමානතාවයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටී."

තර්කණය සහ හේතු සාධකය:

- 'කාන්තාවන් සහ සෞඛ්‍යය' පිළිබඳ CEDAW පොදු නිර්දේශ අංක 24 හි 31(a) වගන්තියේ සඳහන් වන පරිදි රාජ්‍ය පාර්ශ්වකරුවන් විසින් "කාන්තා සෞඛ්‍යයට බලපාන සියලු ම ප්‍රතිපත්ති සහ වැඩසටහන්වල ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණය කේන්ද්‍රීය ලෙස තබා ගත යුතු" යි.

නිර්දේශ අංක 2

➤ 5 පිටුව, අවසාන ඡේදය, දෙවන ඡේදය

දැනට පවතින වගන්තිය:

- "වෙනස් වන සෞඛ්‍ය වපසරිය තුළ ඇතිවෙන සද්චාරාත්මක අභියෝග හේතුවෙන් ඒ තුළට ශක්තිමත් නීතිමය සහ නියාමන රාමු සඳහා අවශ්‍යතාවක් පැන නගී. ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අතරට ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය, නාගරික සෞඛ්‍ය සේවා පාලනය සහ සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා කෘතිම බුද්ධියේ සද්චාරාත්මක භාවිතය ඇතුළත් වේ. මහජන සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ අධීක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ආහාර ඇතුළු භාෂිකර ද්‍රව්‍ය සහ නිෂ්පාදන නියාමනය කිරීම සඳහා ද නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය වේ."

නිර්දේශිත සංශෝධනය (නිල් පැහැයෙන්):

- "වෙනස් වන සෞඛ්‍ය වපසරිය තුළ ඇතිවෙන සද්චාරාත්මක අභියෝග හේතුවෙන් ඒ තුළට ශක්තිමත් නීතිමය සහ නියාමන රාමු සඳහා අවශ්‍යතාවක් පැන නගී. ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර අතරට ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය හා අයිතිවාසිකම්, නාගරික සෞඛ්‍ය සේවා පාලනය සහ සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා සද්චාරාත්මකව කෘතිම බුද්ධිය භාවිතය ඇතුළත් වේ. අවදානමට ලක්වූ කණ්ඩායම් ඇතුළුව සියලු ම පුරවැසියන් සඳහා වෙනස්කම්කිරීම් වලට ලක්වීමකින් තොර ව සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් සහතික කිරීම සඳහා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ කඩිනමින් අවශ්‍ය වේ. මහජන සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ අධීක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ආහාර ඇතුළු භාෂිකර ද්‍රව්‍ය සහ නිෂ්පාදන නියාමනය කිරීම සඳහා ද තවදුරටත් රෙගුලාසි අවශ්‍ය වේ."

තර්කණය සහ හේතු සාධකය:

- ‘ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සහ අයිතිවාසිකම්’ (SRHR) යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ CEDAW සම්මුතිය මගින් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගෙන සම්මත කර ඇති පාරිභාෂික වාක්‍ය කාණ්ඩයකි. ‘කාන්තාවන් සහ සෞඛ්‍යය’ පිළිබඳ CEDAW සාමාන්‍ය නිර්දේශ අංක 24 හි 18 වන වගන්තිය පහත පරිදි වේ:

"HIV/AIDS සහ අනෙකුත් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග පිළිබඳ ගැටලු කාන්තාවන්ගේ සහ නව යොවුන් වියේ ගැහැනු ළමයින්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම් සඳහා කේන්ද්‍රීය වේ. බොහෝ රටවල නව යොවුන් වියේ ගැහැනු ළමයින්ට සහ කාන්තාවන්ට ලිංගික සෞඛ්‍යය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍යවන තොරතුරු සහ සේවාවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශයක් නොමැත. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ අසමාන බල සම්බන්ධතාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, කාන්තාවන්ට සහ නව යොවුන් වියේ ගැහැනු ළමයින්ට බොහෝ විට ලිංගිකව හැසිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ ආරක්ෂිත සහ වගකිවයුතු ලිංගික සම්බන්ධතාවක අවශ්‍යතාව අවධාරනය කිරීමට ඉඩක් නොමැත. කාන්තා ලිංගඡේදනය, බහු විවාහ මෙන් ම වෛවාහික දූෂණය වැනි හානිකර සාම්ප්‍රදයික පිළිවෙත්ද, ගැහැනු ළමයින් සහ කාන්තාවන් HIV/AIDS සහ අනෙකුත් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග වැළඳීමේ අවදානමට නිරාවරණය කළ හැකිය. ... විශේෂයෙන් ම, රාජ්‍ය පාර්ශවයන් විසින් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට සහ රහස්‍යභාවයට ඇති අයිතියට ගරු කරන ඒ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද වැඩසටහන් හරහා නිසි පුහුණුව ලත් පිරිස් විසින් ලබා දෙන අධ්‍යාපනය තුළින් කාන්තා හා පිරිමි යෙහෙවන යෙහෙවතියන්ගේ ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම් සහතික කළ යුතු ය."

- ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව (පිටුව 9) පහත සඳහන් ප්‍රතිපත්ති මූලධර්මය ගැන සඳහන් කරයි: 1981 දී ශ්‍රී ලංකාව විසින් අනුමත කරන ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ CEDAW සම්මුතිය වැනි ‘ගෝලීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල සෞඛ්‍ය සේවා.
- ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවේ (පිටුව 47) ‘ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්’ යටතේ “සියලු වයස් කාණ්ඩ සඳහා සකස් කරන ලද පුළුල් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සහ සේවාවන්” ගැන සඳහන් වේ.

නිර්දේශ අංක 3
➤ 6 පිටුව, අරමුණ සහ සන්දර්භය

දැනට පවතින වගන්තිය:

- “එය නිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs), විශේෂයෙන් ඉලක්කය 3, WHO ගෝලීය සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම රාමුව (2025), සහ “ක්‍රමවත් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා තුළින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න වයස්ගත වියක්” (2025) පිළිබඳ කොළඹ ප්‍රකාශනය ඇතුළු ගෝලීය සහ කලාපීය කැපවීම් සමඟ ද අනුකූල වේ.”

නිර්දේශිත සංශෝධනය (නිල් පැහැයෙන්):

- “එය කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් කිරීම් තුරන් කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය (CEDAW), විශේෂයෙන් ම එහි 12 වන වගන්තිය සහ පොදු නිර්දේශ

අංක 24, තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs), විශේෂයෙන් ඉලක්කය 3, WHO ගෝලීය සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම රාමුව (2025), සහ “ක්‍රමවත් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා තුළින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න වයස්ගත වියක්” (2025) පිළිබඳ කොළඹ ප්‍රකාශනය ඇතුළු ගෝලීය සහ කලාපීය කැපවීම් සමග ද අනුකූල වේ.”

තර්කණය සහ හේතු සාධකය:

- ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවේ (පිටුව 46) ප්‍රතිපත්ති මූලධර්මයක් ලෙස ‘එක්සත් ජාතීන්ගේ CEDAW සම්මුතිය මගින් නියම කර ඇති ප්‍රමිතීන් සහිත දේශීය නීති’ සහතික කිරීම ගැන සඳහන් කරයි.
- ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ CEDAW සම්මුතියේ රාජ්‍ය පාර්ශ්වකරුවෙකු වන අතර, 1981 දී ගිවිසුම අනුමත කර ඇති අතර, මෑතක දී 2025 පෙබරවාරි මස දී CEDAW කමිටුවට එහි 9 වන වාර්තාව ඉදිරිපත් කළේය.

නිර්දේශ අංක 4

➤ 9 පිටුව, ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන අංක 12

දැනට පවතින වගන්තිය:

- “කාන්තාවන්ගේ සහ තරුණයින්ගේ සහභාගීත්වය ඇතුළුව ඒකාබද්ධ නිරීක්ෂණ, පර්යේෂණ සහ පුරවැසි හඬ සඳහා ඇති කරන ලද පද්ධති, සාක්ෂි පිළිබඳ දැනුවත්, ප්‍රතිචාරාත්මක තීරණ ගැනීම මෙහෙයවීමට සහ මහජන විශ්වාසය ගොඩනැගීමට හැකි ලෙස ආයතනිකකරණය කර ඇති බව සහතික කිරීම.”

නිර්දේශිත සංශෝධනය (නිල් පැහැයෙන්):

- “කාන්තාවන්ගේ, තරුණයින්ගේ සහ අනෙකුත් සියලු ම වැඩි අවදානමට ලක්වූ සහ කොන්වි ඇති කණ්ඩායම්වල සහභාගීත්වය ඇතුළුව ඒකාබද්ධ නිරීක්ෂණ, පර්යේෂණ සහ පුරවැසි හඬ සඳහා ඇති කරන ලද පද්ධති, සාක්ෂි පිළිබඳ දැනුවත්, ප්‍රතිචාරාත්මක තීරණ ගැනීම මෙහෙයවීමට සහ මහජන විශ්වාසය ගොඩනැගීමට හැකි ලෙස ආයතනිකකරණය කර ඇති බව සහතික කිරීම.”

නිර්දේශ අංක 5

➤ 10 පිටුව, උපායමාර්ගික දිශාව

දැනට පවතින වගන්තිය:

- එක්සත් ජාතීන්ගේ CEDAW සම්මුතිය මගින් තීරණය කර ඇති පරිදි, සෞඛ්‍ය අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැනු ළමයින්ගේ ඇතැම් විශේෂ අවශ්‍යතා, කෙටුම්පත් කර ඇති මෙම ප්‍රතිපත්තිය විසින් හඳුනා නොගනී.

නිර්දේශිත සංශෝධනය (නිල් පැහැයෙන්):

- මෙම හිඬැස පිරවීමට නව උපායමාර්ගික දිශාවක් ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා කිරීම.
- නව උපායමාර්ගික දිශාව පහත පරිදි වේ:

- “නව යොවුන් වියේ සිට වැඩිහිටි විය දක්වා වන වෙනස්වන සුළු සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දක්වන සහ සමානාත්මතාවය සහ සාධාරණත්වය ප්‍රවර්ධනය කරන අයිතිවාසිකම් මත පදනම් වූ මගක් ගනිමින්, කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැනු ළමයින්ගේ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම සඳහා වූ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් ලබා දෙන බව සහතික කිරීම.”

තර්කණය සහ හේතු සාධකය:

- ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 51.7% ක් කාන්තාවන් වන අතර¹, කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරා ම, එනම් ඔසප් වීමේ සිට ආර්තවහරණය දක්වා සහ ඉන් ඔබ්බට විශේෂ ලිංගික සහ ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා ඇත.
- ‘කාන්තාවන් සහ සෞඛ්‍යය’ පිළිබඳ CEDAW පොදු නිර්දේශ අංක 24 හි 12 වන වගන්තියේ පහත සඳහන් කරුණු සඳහන් වේ:

“සෞඛ්‍ය සේවා පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාමාර්ග කාන්තාවන්ගේ අවශ්‍යතා සහ ඔවුන් උනන්දුවන කාරණා පිළිබඳ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කටයුතු කරන ආකාරය සහ පිරිමින්ට සාපේක්ෂව කාන්තාවන් වෙනස් වන සුවිශේෂී ලක්ෂණ සහ සාධක හඳුනාගනිමින් කටයුතු කරන ආකාරය ගැන ඔවුන් තුළ ඇති අවබෝධය පිළිබඳව රාජ්‍ය පාර්ශවකරුවන් වාර්තා කළ යුතුය, එනම්:

අ) කාන්තාවන්ගේ ඔසප් චක්‍රය, ප්‍රජනක ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ආර්තවහරණය වැනි පිරිමින්ට සාපේක්ෂව වෙනස් වන ජීව විද්‍යාත්මක සාධක. තවත් උදාහරණයක් වන්නේ කාන්තාවන් ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගවලට නිරාවරණය වීමේ වැඩි අවදානමක සිටීම යි;

ආ) සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන්ට සහ විශේෂයෙන් සමහර කාන්තා කණ්ඩායම් සඳහා වෙනස් වන සමාජ-ආර්ථික සාධක. නිදසුනක් වශයෙන්, නිවසේ සහ රැකියා ස්ථානයේ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් අතර ඇති අසමාන බල සබඳතා කාන්තාවන්ගේ පෝෂණයට සහ සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි ය. ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපාන විවිධ ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයන්ට ද ඔවුන් නිරාවරණය විය හැකිය. ගැහැනු ළමයින් සහ නව යොවුන් වියේ ගැහැනු ළමයින් බොහෝ විට වැඩිහිටි පිරිමින් සහ පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් ලිංගික අපයෝජනයට ලක්වන අතර, ඔවුන් ශාරීරික හා මානසික හානිවලට සහ අනවශ්‍ය සහ නිසි වයසට පෙර ගැබ්ගැනීම්වලට ගොදුරු වීමේ අවදානමට ලක් වේ. කාන්තා ලිංගපේදනය වැනි සමහර සංස්කෘතික හෝ සාම්ප්‍රදයික පිළිවෙත් මරණයට පත්වීමේ හා ආබාධිතභාවයට පත්වීමේ අවදානම ඉහළ නංවයි.

¹ ජන හා නිවාස සංගණනයේ අවසන් වාර්තාව, 2024 [සබැඳිය]

නිර්දේශ අංක 6

➤ **12 පිටුව, ඇමුණුම 1, නව උපායමාර්ගික දිශා සඳහා උපාය මාර්ග**

දැනට පවතින වගන්තිය:

- දැනට වගන්තියක් නැත.

නිර්දේශිත සංශෝධනය (නිල් පැහැයෙන්):

- ඉහත නිර්දේශ අංක 6 හි සඳහන් නව උපායමාර්ගික දිශාව යටතේ පහත සඳහන් උපාය මාර්ග ඇතුළත් කිරීම: *“නව යොවුන් වියේ සිට වැඩිහිටි විය දක්වා වන වෙනස්වන සුළු සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දක්වන සහ සමානාත්මතාවය සහ සාධාරණත්වය ප්‍රවර්ධනය කරන අයිතිවාසිකම් මත පදනම් වූ මගක් ගනිමින්, කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැනු ළමයින්ගේ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවාට විසඳුම් ලබා දෙන බව සහතික කිරීම.”*
- නව උපායමාර්ගික මග පෙන්වීම යටතේ යෝජිත උපායමාර්ග:
 - සියලු ම කාන්තාවන්ට සහ ගැහැනු ළමයින්ට වෙනස්කොට සැලකීමිච්චින් තොර, සමානාත්මතාවය, ගෞරවය සහ ස්වයං තීරණ ගැනීමේ අයිතිය, රහස්‍යභාවය සහ දැනුවත් කිරීමකින් අනතුරුව තෝරාගැනීමට ඉඩහරින්න සෞඛ්‍ය සේවාවක්, විශේෂයෙන් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සහ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශයක් ඇති බව සහතික කිරීම. ළමා විය, නව යොවුන් විය, මැදිවියේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වා වන ජීවන චක්‍රය ආවරණය වන ප්‍රවේශයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම.
 - ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යාපනයක් ප්‍රවර්ධනය කරන සහ කාන්තා ලිංගඡේදනය, ළමා විවාහ සහ නව යොවුන් වියේ ගැබ්ගැනීම් වැනි හානිකර සාම්ප්‍රදයික පිළිවෙත්වලින් දරුවන් ආරක්ෂා කරන නව යොවුන් වියට හිතකාමී සෞඛ්‍ය සේවාවන් සහතික කිරීම.
 - වැඩි අවදානමට ලක්වූ සහ ආන්තික කණ්ඩායම් ඇතුළු ව සියලු ම කාන්තාවන්ට නවීන පවුල් සැලසුම් සේවා සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් සහ සම්මත පූර්ව ප්‍රසව සහ පසු ප්‍රසව සත්කාර සමග ආරක්ෂිත ගැබ් ගැනීමක් සහතික කිරීම.
 - ගර්භනී කාන්තාවන් හෝ පසු ප්‍රසව කාලය තුළ සිටින කාන්තාවන්, ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වූ කාන්තාවන් සහ වැටුප් නොලබන සුරැකුම් සේවාවලින් පීඩාවට පත්ව සිටින කාන්තාවන් සඳහා මානසික සෞඛ්‍ය සේවා ශක්තිමත් කිරීම.
 - බෝ නොවන රෝග, පියයුරු පිළිකා, ගැබ්ගෙල පිළිකා සහ ඔස්ටියෝපොරෝසිස් සඳහා පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළු රෝස වලක්වා ගැනීමේ සේවා සැපයීම ශක්තිමත් කිරීම.
 - ගෘහස්ථ හිංසනය ඇතුළුව සියලු ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයන්ට ගොදුරු වූවන් සඳහා දිවි ගලවා ගත් අය කේන්ද්‍ර කරගත් සත්කාර ලබා දීමේ දී බහු අංශ සම්බන්ධීකරණ ප්‍රවේශයක් (සෞඛ්‍ය, යුක්තිය සහ සමාජ සේවා) හරහා ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ සෞඛ්‍ය සේවා සහතික කිරීම.
 - කාන්තාවන් සිදු කරන වැටුප් නොලබන සුරැකුම් සේවා හඳුනා ගැනීම සහ ඔවුන්ට ප්‍රමාණවත් සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන් සංඛ්‍යාවක් සිටින ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී සෞඛ්‍ය සේවාවන් සහතික කිරීම.

8. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අයවැයකරණය, කාන්තාවන්ට ආවේණික සෞඛ්‍ය ගැටලු පිළිබඳ පර්යේෂණ, සායනික අත්හදා බැලීම්වලට කාන්තාවන් ඇතුළත් කිරීම, මැනිය හැකි ප්‍රගතියක් සහතික කිරීම සඳහා, සාධාරණ හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට සංවේදී සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල ළඟා කරගැනීම වෙනුවෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අනුව වෙන් කරන ලද දත්ත කළමනාකරණ පද්ධති නිර්මාණය කිරීම.

තර්කණය සහ හේතු සාධකය:

- ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවේ (පිටුව 47) 'ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්' යටතේ "සියලු වයස් කාණ්ඩ සඳහා සකස් කරන ලද විධිමත් ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය සහ සේවාවන්" ගැන සඳහන් වේ.
- ඉහත සඳහන් කළ පරිදි නිර්දේශිත උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම සහ ඇතුළත් කිරීමේ වැදගත්කම පහත දත්ත මගින් ද පෙන්වනු ලබයි:
 - ශ්‍රී ලංකාවේ ගැබ්නී මව්වරුන්ගෙන් 3.8% ක්² නව යොවුන් වියේ ගැහැනු ළමයින් වන අතර ඔවුන් ප්‍රසව සංකූලතාවලට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත.
 - වයස අවුරුදු 15-24 අතර නව යොවුන් වියේ පසුවන්නන් සහ තරුණ තරුණියන් ආසන්න වශයෙන් 15% ක් ලිංගිකව ක්‍රියාකාරී අය වෙති.³
 - කාන්තාවන් අතර වඩාත් සුලභ පිළිකාව වන පියයුරු පිළිකාව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ හඳුනාගන්නේ ප්‍රමාද වී ය.⁴
 - කාන්තාවන්ගෙන් 44% ක් අධික බර හෝ තරබාරුබවින් පෙළීම සහ කාන්තාවන්ගෙන් 14.7 ක් දියවැඩියා රෝගීන් වීම යන දත්තවලින් පෙනී ය පරිදි කාන්තාවන් බෝ නොවන රෝගවලට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් සිටී.⁵

² කෙටි වාර්තාව: ශ්‍රී ලංකාවේ නව යොවුන් වියේ ගැබ් ගැනීම් - ප්‍රවණතා සහ තීරණාත්මක සාධක, UNFPA, 2024 [\[සබැඳිය\]](#)

³ ශ්‍රී ලංකා ජාතික තරුණ සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණය (2012/2013), පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය, 2015 [\[සබැඳිය\]](#)

⁴ ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ දත්ත.

⁵ බෝ නොවන රෝග අවදානම් සාධක පිළිබඳ සමීක්ෂණය (STEPS සමීක්ෂණය), සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව, 2021 [\[සබැඳිය\]](#)